

**LAPORAN EVALUASI KESEHATAN GIGI DAN MULUT SERTA KESEHATAN
MASYARAKAT DI POSYANDU WILAYAH KELURAHAN BARUGA DAN
WUNDUDOPI**



Disusun oleh :

Nama : drg. M. Aksa Arsyad, S.KG

Wahana : Puskesmas Lepo-Lepo

Pendamping :

drg. Eka Sulistianingrum, MARS

**PROGRAM INTERNSIP DOKTER GIGI INDONESIA
ANGKATAN I TAHUN 2026
BLUD UPTD PUSKESMAS LEPO-LEPO
KOTA KENDARI
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari status kesehatan sistemik dan kualitas hidup manusia secara holistik. Dalam kerangka kesehatan masyarakat global, *World Health Organization* (WHO) secara konsisten menegaskan bahwa penyakit gigi dan mulut, yang didominasi oleh karies gigi dan penyakit periodontal, merupakan kelompok Penyakit Tidak Menular (PTM) yang paling umum terjadi, membebani lebih dari 2,5 miliar penduduk di seluruh dunia.¹ Karies gigi sendiri didefinisikan sebagai penyakit infeksius dan proses patologis multifaktorial yang dimediasi oleh keberadaan biofilm asidogenik (plak bakteri) pada permukaan gigi. Interaksi kompleks antara mikroorganisme kariogenik, substrat karbohidrat yang dapat difermentasi, kerentanan jaringan pejamu atau *host tissue* (gigi dan saliva), serta durasi waktu paparan, secara kolektif memicu terjadinya proses demineralisasi progresif pada jaringan keras email dan dentin.² Keberadaan lesi karies yang tidak tertangani bukan sekadar masalah estetika, melainkan bermuara pada komplikasi yang lebih parah seperti rasa nyeri akut, bakteremia, gangguan fungsi pengunyahan, penurunan asupan nutrisi, gangguan pola tidur, hingga penurunan produktivitas kerja dan prestasi akademik pada anak-anak.³

Mengkaji fenomena ini dalam konteks nasional, Indonesia masih menghadapi beban penyakit gigi dan mulut yang tergolong masif dan memprihatinkan. Berdasarkan rilis Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, tercatat bahwa 56,9% dari total penduduk berusia tiga tahun ke atas mengalami gangguan atau masalah kesehatan gigi dan mulut dalam satu tahun terakhir. Lebih spesifik lagi, SKI 2023 melaporkan bahwa prevalensi karies gigi nasional bertengger pada angka yang sangat tinggi, yakni mencapai 82,8%. Tingginya prevalensi ini berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran dan utilitasi layanan medis klinis, di mana hanya sekitar 11,2% dari populasi bermasalah tersebut yang secara proaktif mencari dan mendapatkan penanganan medis dari tenaga kesehatan gigi profesional.⁴ Realitas ini mencerminkan adanya defisit kesehatan oral, hambatan aksesibilitas pelayanan, serta belum optimalnya upaya promotif dan preventif.⁵

Menelusuri dinamika kesehatan gigi di tingkat regional, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, turut merepresentasikan tantangan serupa. Data dari Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 memperlihatkan bahwa proporsi masalah gigi berlubang, rusak, dan sakit di Kota Kendari mencapai angka 45,24%. Tren epidemiologis di wilayah ini menunjukkan peningkatan beban morbiditas yang didorong oleh perilaku kebersihan mulut yang suboptimal. Sebagian besar masyarakat, kendati mengetahui pentingnya menyikat gigi, belum mempraktikkan kebiasaan tersebut pada waktu yang krusial yakni setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Disparitas antara pengetahuan kognitif dan implementasi perilaku kebersihan mulut (*oral hygiene behavior*) ini menjadi faktor risiko determinan yang mengakselerasi pembentukan kavitas pada berbagai lapisan usia.⁶

Secara epidemiologi karies, terdapat dua kelompok demografis yang menempati hierarki risiko kerentanan tertinggi, yakni ibu hamil dan anak balita. Pada ibu hamil, kerentanan ini dipengaruhi oleh perubahan fisiologis, psikologis, dan endokrinologis yang signifikan selama masa kehamilan. Terjadinya lonjakan sekresi hormon steroid seks, secara khusus estrogen dan progesteron, memicu peningkatan permeabilitas vaskular dan eksudasi cairan krevikular gingiva, yang menyebabkan jaringan penyangga gigi menjadi hiper-responsif terhadap iritasi plak lokal.⁷ Kondisi ini bermanifestasi sebagai gingivitis kehamilan yang sering kali disertai perdarahan spontan saat menyikat gigi. Rasa tidak nyaman dan nyeri inflamasi tersebut menginduksi keengganan ibu hamil untuk menjaga higienitas lisan secara optimal. Di samping itu, komplikasi gastrointestinal awal kehamilan seperti *emesis gravidarum* (mual dan muntah) menyebabkan refluks asam lambung korosif yang mereduksi pH saliva ke tingkat asidik, memfasilitasi erosi email.⁷ Upaya menekan rasa mual ini umumnya dikompensasi oleh ibu hamil dengan meningkatkan frekuensi konsumsi panganan ringan manis dan kariogenik. Akumulasi dari asiditas rongga mulut, diet tinggi sukrosa, dan penurunan frekuensi pembersihan mekanis ini menyebabkan ibu hamil memiliki indeks DMF-T (*Decayed, Missing, Filled-Teeth*) yang secara signifikan lebih buruk. Penanganan yang lambat terhadap infeksi karies dan periodontal pada fase maternal ini telah terbukti secara ilmiah memiliki korelasi sistemik dengan risiko kelahiran prematur (*preterm birth*) dan berat badan lahir rendah (*low birth weight*).⁹

Di sisi lain, kelompok anak di bawah usia lima tahun (balita) menghadapi patologi destruktif yang diklasifikasikan sebagai *Early Childhood Caries* (ECC). ECC didefinisikan sebagai kehadiran satu atau lebih permukaan gigi desidui yang mengalami kavitas, hilang

akibat karies, atau telah ditambal pada anak berusia 71 bulan atau lebih muda.¹⁰ SKI 2023 mengekspos fakta kelam bahwa prevalensi karies pada anak usia dini di Indonesia menyentuh angka 84,8%.⁴ Etiologi ECC sangat erat kaitannya dengan praktik pengasuhan dan pemberian makan (*feeding practices*) yang tidak tepat, utamanya *prolonged bottle-feeding* atau kebiasaan memberikan susu botol formula yang disubstitusi gula sebagai pengantar tidur di malam hari.¹¹ Saat balita tertidur pulas, laju sekresi kelenjar saliva dan aktivitas menelan menurun secara drastis, sehingga cairan kariogenik menggenang (*pooling*) dan membasahi area gigi insisivus rahang atas selama berjam-jam. Lingkungan kaya karbohidrat ini menjadi medium kultur sempurna bagi mikroorganisme asidogenik primer seperti *Streptococcus mutans* dan *Weillonella spp.* untuk melakukan fermentasi, memproduksi asam laktat, dan mendemineralisasi email gigi sulung yang secara anatomis memang lebih tipis dan rentan dibandingkan gigi permanen.¹² Karies dini yang meluas pada balita merusak fungsi mastikasi, mengganggu penyerapan nutrisi esensial yang berujung pada ancaman *stunting*, memicu gangguan wicara, serta mendegradasi kualitas hidup anak di masa keemasan perkembangannya.³

Menyikapi kompleksitas dan signifikansi permasalahan tersebut, pendekatan kuratif reaktif yang eksklusif bertumpu pada intervensi dalam gedung puskesmas terbukti tidak memadai. Diperlukan sebuah reorientasi strategis yang memprioritaskan promosi kesehatan dan prevensi penyakit langsung di episentrum komunitas. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memegang peranan krusial sebagai bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Melalui integrasi program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) ke dalam rutinitas Posyandu, rantai patogenesis karies dapat diputus sedini mungkin. UKGM memfasilitasi pemberdayaan kader kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan proaktif, deteksi dini (*skrining*), dan rujukan kasus karies pada kelompok sasaran risiko tinggi, mencakup ibu hamil dan balita, sejalan dengan visi "Indonesia Bebas Karies 2030".¹³

Implementasi program UKGM ini telah dilangsungkan secara komprehensif di wilayah kerja pelayanan kesehatan primer Kota Kendari, secara spesifik menasar sembilan Posyandu yang beroperasi di wilayah administratif Kelurahan Baruga dan Kelurahan Wundudopi. Mengingat krusialnya efektivitas intervensi komunitas ini, sebuah evaluasi yang sistematis, terukur, dan berbasis data objektif mutlak diperlukan. Laporan evaluasi ini

disusun untuk prevalensi kesehatan gigi dan mulut di kedua kelurahan tersebut, menganalisis faktor-faktor determinan lokal yang berkontribusi terhadap insidensi karies, serta rekomendasi strategis yang aplikatif. Evaluasi ini menjadi representasi konkret dari komitmen akademik dan praktis dalam kesenjangan kesehatan oral, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal, dan memperkuat resiliensi sistem kesehatan masyarakat dalam menghadapi tantangan penyakit tidak menular di era modern.

1.2 Pertanyaan Evaluasi

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran tingkat kesehatan gigi (karies dan bebas karies) pada ibu hamil dan balita di Posyandu Kelurahan Baruga dan Wundudopi?
2. Faktor apa saja (pola makan, pola asuh seperti penggunaan dot, psikologis, dan perubahan hormon) yang memperparah karies gigi pada kelompok tersebut?
3. Strategi pencegahan dan intervensi apa yang paling tepat untuk meningkatkan program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) dan kemampuan kader Posyandu di wilayah tersebut?

1.3 Tujuan Evaluasi

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persentase kejadian karies gigi pada ibu hamil dan balita di Posyandu Kelurahan Baruga dan Wundudopi sebagai data dasar evaluasi kesehatan.
2. Mengidentifikasi penyebab karies, seperti gaya hidup, kurangnya pengetahuan kebersihan mulut, kebiasaan ngedot di malam hari, dan keengganan ibu hamil memeriksakan gigi.
3. Menyusun rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan program UKGM, melatih kader Posyandu, dan memperbaiki sistem rujukan kesehatan.

1.4 Manfaat Evaluasi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Puskesmas:
Sebagai panduan berbasis data untuk merencanakan program kegiatan, mengalokasikan anggaran, dan menempatkan tenaga medis secara lebih tepat sasaran.

2. Bagi Masyarakat dan Kader Posyandu:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya karies pada anak dan ibu hamil, serta menjadi acuan bagi kader untuk meningkatkan kualitas penyuluhan kesehatan.

3. Bagi Akademisi & Ilmu Pengetahuan:

Menjadi referensi literatur untuk penelitian selanjutnya, khususnya terkait kesehatan gigi masyarakat di Indonesia Timur, dan membantu pengembangan metode penyuluhan yang sesuai dengan budaya setempat.

BAB II

METODE

2.1 Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data primer dilakukan secara langsung ke lapangan pada rentang waktu Maret hingga April 2026. Sasarannya difokuskan pada kelompok rentan, yakni ibu hamil dan balita yang aktif mengikuti kegiatan Posyandu. Agar hasilnya benar-benar mewakili masyarakat, pemeriksaan disebar di sembilan Posyandu, dengan rincian enam titik di Kelurahan Baruga dan tiga titik di Kelurahan Wundudopi. Di lokasi tersebut, tim pemeriksa melakukan skrining kondisi gigi secara visual menggunakan alat dasar kedokteran gigi dengan penerapan standar sterilisasi yang sangat ketat. Hasil pemeriksaan dikelompokkan secara sederhana ke dalam dua kategori, yaitu "Karies" (gigi berlubang) atau "Tidak Karies" (gigi sehat). Untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya, seluruh temuan klinis ini langsung dicatat dengan rapi dan disinkronkan dengan data kehadiran pada buku register masing-masing Posyandu.

2.2 Pengolahan Data

Setelah seluruh rangkaian kegiatan lapangan rampung pada akhir April 2026, data yang terkumpul mulai diolah. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembersihan data, di mana tim menyisir catatan untuk membuang data yang ganda, salah tulis, maupun tidak lengkap. Hanya data yang benar-benar utuh dan valid yang kemudian dikelompokkan berdasarkan wilayah (Kelurahan dan Posyandu) serta kategori usianya (ibu hamil dan balita). Selanjutnya, jumlah kasus karies dan tidak karies dihitung lalu diubah ke dalam bentuk persentase. Konversi menjadi persentase ini sangat penting untuk memastikan perbandingan tingkat kesehatan antar-Posyandu tetap adil dan akurat, terlepas dari perbedaan jumlah pengunjung di tiap lokasi. Pada akhirnya, hasil analisis ini disajikan dalam perpaduan tabel dan penjelasan naratif yang lugas. Pendekatan ini bertujuan agar laporan mudah dipahami oleh tenaga medis maupun pembuat kebijakan daerah, sehingga dapat langsung dijadikan pijakan yang kuat untuk merancang program kesehatan gigi yang tepat sasaran di tahun berikutnya.

BAB III

HASIL

Kegiatan pemeriksaan skrining kesehatan gigi dan mulut yang diintegrasikan dengan program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) ini telah sukses direalisasikan di wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan yang menaungi Kelurahan Baruga dan Kelurahan Wundudopi. Operasional lapangan mencakup total 9 (sembilan) titik Posyandu aktif yang melayani masyarakat setempat secara periodik. Pada lanskap Kelurahan Baruga, cakupan evaluasi meninjau 6 Posyandu, yakni Posyandu Boegenvil, Posyandu Nanga-nanga, Posyandu GBI, Posyandu Latjinta II, Posyandu Raksa Asri, dan Posyandu Nusa Indah. Sementara pada zonasi Kelurahan Wundudopi, intervensi pemeriksaan dilangsungkan di 3 Posyandu, meliputi Posyandu Bukit Indah, Posyandu Elektrik, dan Posyandu Asoka. Tabulasi data hasil penjangkauan ini disusun secara hierarkis untuk memetakan beban penyakit spesifik pada masing-masing kelompok demografis.

3.1 Distribusi kelompok sasaran pemeriksaan di Kelurahan Baruga dan Wundudopi

Tabel 3.1 Distribusi kelompok sasaran pemeriksaan di Kelurahan Baruga dan Wundudopi

Kelompok Sasaran	n	%
Ibu Hamil	19	23,17
Balita	63	76,83
Total	82	100

Berdasarkan tabel 3.1 hasil distribusi kumulatif kelompok sasaran yang berhasil dijangkau dan diperiksa selama periode observasi di kedua kelurahan, dengan partisipan mencapai 82 orang. Partisipasi dari kelompok balita (usia 1-5 tahun) memegang proporsi mayoritas dengan jumlah 63 balita, yang merepresentasikan 76,83% dari total keseluruhan sampel penelitian. Di sisi lain, partisipasi dari kelompok sasaran ibu hamil berada pada jumlah 19 orang dengan persentase 23,17%.

3.2 Gambaran Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Ibu Hamil di Posyandu Kelurahan Baruga dan Wundudopi

Tabel 3.2 Distribusi hasil pemeriksaan pada ibu hamil di Kelurahan Baruga

Posyandu	Hasil Pemeriksaan		Jumlah yang diperiksa (%)
	Karies (%)	Tidak Karies (%)	
Boegenvil	5 (50,0)	5 (50,0)	10 (58,8)
Nanga-nanga	2 (100,0)	0 (0,0)	2 (11,8)
GBI	0 (0,0)	1 (100,0)	1 (5,9)
Latjinta II	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Raksa Asri	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)

Nusa Indah	2 (50,0)	2 (50,0)	4 (23,5)
Total	9 (52,9)	8 (47,1)	17 (100,0)

Tabel 3.2 memaparkan hasil pemeriksaan status kesehatan gigi pada 17 ibu hamil di Kelurahan Baruga. Secara keseluruhan, angka kejadian karies tampak sedikit lebih dominan dengan 9 orang (52,9%) terdiagnosis karies, sedangkan 8 orang (47,1%) berstatus bebas karies. Jika dirinci berdasarkan lokasi layanan, Posyandu Boegenvil mencatat tingkat kehadiran sasaran tertinggi, yaitu 10 orang. Pada lokasi ini, proporsi kejadian karies dan non-karies sebanding, yakni masing-masing 5 orang (50,0%). Pola persentase yang seimbang ini juga terlihat pada Posyandu Nusa Indah dengan total 4 partisipan, di mana 2 orang (50,0%) teridentifikasi karies dan 2 orang (50,0%) lainnya bebas karies. Sementara itu, seluruh partisipan di Posyandu Nanga-nanga yang berjumlah 2 orang (100,0%) terdiagnosis mengalami karies. Sebaliknya, pada Posyandu GBI, satu-satunya ibu hamil yang diperiksa (100,0%) tercatat bebas dari karies. Di sisi lain, Posyandu Latjinta II dan Posyandu Raksa Asri sama sekali tidak mencatat adanya kunjungan sasaran ibu hamil pada periode pemeriksaan ini (n=0).

Tabel 3.3 Distribusi hasil pemeriksaan pada ibu hamil di Kelurahan Wundudopi

Posyandu	Hasil Pemeriksaan		Jumlah yang diperiksa (%)
	Karies (%)	Tidak Karies (%)	
Bukit Indah	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Elektrik	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Asoka	2 (100,0)	0 (0,0)	2 (100,0)
Total	2 (100,0)	0 (0,0)	2 (100,0)

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diketahui distribusi hasil pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil di Kelurahan Wundudopi, diperoleh jumlah keseluruhan sasaran yang diperiksa sebanyak 2 orang. Pemeriksaan dilakukan di tiga Posyandu, yaitu Posyandu Bukit Indah, Posyandu Elektrik, dan Posyandu Asoka. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 2 orang (100,0%) mengalami karies, sedangkan 0 orang (0,0%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu Bukit Indah, jumlah ibu hamil yang diperiksa sebanyak 0 orang (0,0%). Pada Posyandu Elektrik, jumlah ibu hamil yang diperiksa sebanyak 0 orang (0,0%). Pada Posyandu Asoka, jumlah ibu hamil yang diperiksa sebanyak 2 orang (100,0%) dan seluruhnya mengalami karies.

3.3 Gambaran Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Balita di Posyandu Kelurahan Baruga dan Wundudopi

Tabel 3.4 Distribusi hasil pemeriksaan pada balita di Kelurahan Baruga

Posyandu	Hasil Pemeriksaan		Jumlah yang diperiksa (%)
	Karies (%)	Tidak Karies (%)	
Boegenvil	3 (75,0)	1 (25,0)	4 (7,4)
Nanga-nanga	6 (60,0)	4 (40,0)	10 (18,5)
GBI	1 (12,5)	7 (87,5)	8 (14,8)
Latjinta II	1 (20,0)	4 (80,0)	5 (9,3)
Raksa Asri	1 (25,0)	3 (75,0)	4 (7,4)
Nusa Indah	11 (47,8)	12 (52,2)	23 (42,6)
Total	23 (42,6)	31 (57,4)	54 (100,0)

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui distribusi hasil pemeriksaan gigi dan mulut pada balita di Kelurahan Baruga, diperoleh jumlah keseluruhan sasaran yang diperiksa sebanyak 54 orang. Pemeriksaan dilakukan di enam Posyandu, yaitu Posyandu Boegenvil, Posyandu Nanga-nanga, Posyandu GBI, Posyandu Latjinta II, Posyandu Raksa Asri, dan Posyandu Nusa Indah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 23 orang (42,6%) mengalami karies, sedangkan 31 orang (57,4%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu Boegenvil, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 4 orang, ditemukan 3 orang (75,0%) mengalami karies dan 1 orang (25,0%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu Nanga-nanga, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 10 orang, ditemukan 6 orang (60,0%) mengalami karies dan 4 orang (40,0%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu GBI, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 8 orang, ditemukan 1 orang (12,5%) mengalami karies dan 7 orang (87,5%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu Latjinta II, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 5 orang, ditemukan 1 orang (20,0%) mengalami karies dan 4 orang (80,0%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu Raksa Asri, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 4 orang, ditemukan 1 orang (25,0%) mengalami karies dan 3 orang (75,0%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu Nusa Indah, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 23 orang, ditemukan 11 orang (47,8%) mengalami karies dan 12 orang (52,2%) tidak mengalami karies.

Tabel 3.5 Distribusi hasil pemeriksaan pada balita di Kelurahan Wundudopi

Posyandu	Hasil Pemeriksaan		Jumlah yang diperiksa (%)
	Karies (%)	Tidak Karies (%)	
Bukit Indah	2 (50,0)	2 (50,0)	4 (44,4)
Elektrik	1 (100,0)	0 (0,0)	1 (11,1)
Asoka	2 (50,0)	2 (50,0)	4 (44,4)
Total	5 (55,6)	4 (44,4)	9 (100,0)

Berdasarkan Tabel 3.5, dapat diketahui distribusi hasil pemeriksaan gigi dan mulut pada balita di Kelurahan Wundudopi, diperoleh jumlah keseluruhan sasaran yang diperiksa sebanyak 9 orang. Pemeriksaan dilakukan di tiga Posyandu, yaitu Posyandu Bukit Indah, Posyandu Elektrik, dan Posyandu Asoka. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 5 orang (55,6%) mengalami karies, sedangkan 4 orang (44,4%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu Bukit Indah, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 4 orang, ditemukan 2 orang (50,0%) mengalami karies dan 2 orang (50,0%) tidak mengalami karies. Pada Posyandu Elektrik, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 1 orang dan seluruhnya mengalami karies. Sementara itu, pada Posyandu Asoka, jumlah balita yang diperiksa sebanyak 4 orang, ditemukan 2 orang (50,0%) mengalami karies dan 2 orang (50,0%) tidak mengalami karies.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kesehatan Gigi dan Mulut Ibu Hamil dan Balita di Wilayah Kelurahan Baruga dan Wundudopi

Hasil observasi klinis terhadap kesehatan gigi masyarakat di Kelurahan Baruga dan Wundudopi menunjukkan bahwa karies gigi merupakan masalah kesehatan utama pada kelompok rentan. Data gabungan dari kedua wilayah menunjukkan bahwa 57,9% ibu hamil dan 44,4% balita mengalami karies. Angka prevalensi yang tinggi ini sejalan dengan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yang mencatat bahwa 82,8% penduduk Indonesia dan 84,8% anak usia dini menderita karies.⁴ Temuan ini juga memperkuat hasil Riskesdas 2018 di Sulawesi Tenggara mengenai rendahnya penerapan praktik kebersihan rongga mulut preventif.⁶

Berdasarkan hasil pada tabel 3.2 dan tabel 3.3, prevalensi karies pada ibu hamil berkisar antara 52,9% di Baruga hingga 100% di Wundudopi. Tingginya angka kerusakan gigi ini berkaitan dengan perubahan fisiologis selama masa kehamilan. Secara endokrinologis, terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron yang memicu dilatasi pembuluh darah gingiva serta meningkatkan aliran cairan krevikular gingiva (*gingival crevicular fluid*). Kondisi tersebut menyebabkan jaringan periodonsium menjadi lebih sensitif terhadap plak dental, yang sering bermanifestasi sebagai gingivitis gravidarum. Peradangan ini mengakibatkan gusi mudah berdarah dan nyeri saat menyikat gigi. Akibat rasa tidak nyaman tersebut, ibu hamil cenderung menurunkan frekuensi dan kualitas kebersihan mulutnya, sehingga memicu akumulasi bakteri penyebab karies seperti *Streptococcus mutans* dan *Lactobacillus*.⁷

Siklus kerusakan gigi pada ibu hamil diperparah oleh fenomena emesis gravidarum (mual dan muntah) yang umum terjadi pada trimester pertama. Refluks asam lambung (HCl) dapat menurunkan pH saliva secara drastis, sehingga memicu erosi pada email gigi. Untuk menetralkan rasa mual pasca-muntah, ibu hamil sering kali meningkatkan konsumsi makanan ringan yang kaya gula (sukrosa) dengan frekuensi yang tinggi.⁷ Paparan karbohidrat kariogenik yang terus-menerus dalam lingkungan mulut yang asam menyebabkan demineralisasi gigi hingga terbentuk kavitas. Selain itu, adanya stigma mengenai bahaya perawatan gigi bagi janin membuat banyak ibu hamil menghindari fasilitas

kesehatan. Hal ini menyebabkan lesi berkembang menjadi nekrosis pulpa, yang dapat meningkatkan hormon inflamasi sistemik dan berkontribusi pada risiko kelahiran prematur serta berat badan lahir rendah (BBLR).⁹

Pada kelompok balita dapat dilihat tabel 3.4 dan tabel 3.5, hasil evaluasi menunjukkan prevalensi karies sebesar 42,6% di Baruga dan 55,6% di Wundudopi. Kerusakan gigi pada usia prasekolah ini secara klinis dikenal sebagai *Early Childhood Caries* (ECC). ECC merupakan penyakit infeksi multifaktorial progresif yang etiologinya berkaitan erat dengan paparan karbohidrat melalui pola pengasuhan. Tingginya angka ECC, seperti yang ditemukan di Posyandu Boegenvil (75%) dan Elektrik (100%), berkorelasi kuat dengan kebiasaan *prolonged bottle-feeding*. Hal ini mencakup pemberian susu formula dengan tambahan gula menggunakan botol yang melebihi usia penyapihan, terutama jika dilakukan sebagai sarana penenang sebelum tidur malam.¹⁰

Saat balita tidur, laju aliran saliva (*salivary flow rate*) dan frekuensi menelan (*swallowing clearance*) menurun secara signifikan. Sisa susu yang menggenang di area palatal dan sepertiga servikal gigi depan rahang atas difermentasi oleh bakteri asidogenik sepanjang malam. Studi molekuler menunjukkan bahwa simbiosis antara bakteri *Veillonella* spp. dan *S. mutans* meningkatkan risiko karies pada anak penderita *Early Childhood Caries* (ECC) di Indonesia.¹² Selain itu, perbedaan prevalensi karies antarposyandu (seperti 12,5% di GBI dibandingkan 60% di Nanga-nanga) merefleksikan pengaruh determinan sosial kesehatan. Pola makan anak saat ini cenderung didominasi oleh camilan manis dan tepung, sementara asupan sayur dan buah yang mendukung pembersihan alami (*self-cleansing*) masih rendah.¹¹ Kurangnya literasi kesehatan gigi ibu serta rendahnya supervisi orang tua dalam menyikat gigi balita menggunakan pasta gigi ber-*fluoride* dua kali sehari turut menghambat proses remineralisasi alami. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kerusakan gigi yang parah hingga menyisakan akar gigi saja (karies rampan).⁵

4.2 Upaya untuk Meningkatkan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil dan Balita di wilayah Kelurahan Baruga dan Wundudopi

Mengingat tingginya prevalensi dan kompleksitas determinan karies pada ibu hamil dan balita di Kelurahan Baruga dan Wundudopi, pendekatan kesehatan gigi perlu dialihkan dari sekadar kuratif klinis menuju strategi promotif-preventif berbasis komunitas. Strategi utama untuk mengimplementasikan hal ini adalah melalui revitalisasi program Usaha

Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) di tingkat Posyandu.¹³ Program UKGM berlandaskan prinsip *Primary Health Care* untuk mendekatkan layanan edukasi kesehatan kepada kelompok rentan melalui pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan program ini bergantung pada peningkatan kapasitas (*capacity building*) kader Posyandu. Kader berperan sebagai agen perubahan (*change agent*) karena memiliki kedekatan sosial dan budaya dengan masyarakat setempat.¹⁴ Untuk itu, diperlukan pelatihan terstruktur secara berkala dari tenaga kesehatan gigi Puskesmas agar kader mampu menyampaikan edukasi dengan baik. Penggunaan metode permainan edukatif, seperti media "Ular Tangga Kesehatan Gigi", dilaporkan lebih efektif dalam menjaga fokus dan meningkatkan pemahaman sasaran (ibu dan anak) dibandingkan dengan metode ceramah pasif.¹⁶

Untuk populasi ibu hamil, Puskesmas perlu mengintegrasikan "Konseling Prenatal Dental" dan skrining gigi (*dental clearance*) setidaknya pada kunjungan *Antenatal Care* (ANC) trimester pertama. Bidan dan kader kesehatan diharapkan memberikan Anticipatory Guidance, yaitu anjuran untuk berkumur dengan air biasa, air garam, atau larutan baking soda setelah episode mual-muntah. Ibu hamil juga diinstruksikan menunda menyikat gigi selama 30 hingga 60 menit setelah muntah. Penundaan ini penting untuk mencegah abrasi pada email gigi yang sedang melunak akibat paparan asam lambung.⁷ Pemanfaatan media digital, seperti video edukasi, *Augmented Reality* (AR) *e-Pregnant*, hingga *Teledentistry*, dapat dipertimbangkan sebagai sarana interaktif untuk memberikan edukasi mengenai nutrisi anti-kariogenik di rumah.¹⁷

Untuk pencegahan *Early Childhood Caries* (ECC) pada balita, intervensi difokuskan pada modifikasi perilaku pemberian makan (*feeding behavior*). Orang tua perlu diberikan edukasi untuk menghentikan kebiasaan pemberian susu formula bersukrosa melalui botol dot menjelang tidur, dan beralih menggunakan cangkir (*sippy cups*) selambat-lambatnya saat anak berusia satu tahun.¹⁰ Selain itu, penyuluhan di Posyandu perlu mendemonstrasikan cara memposisikan balita saat menyikat gigi (*knee-to-knee positioning*). Menyikat gigi anak sebaiknya dilakukan dua kali sehari (setelah sarapan dan sebelum tidur malam) menggunakan pasta gigi ber-*fluoride* dengan takaran seukuran biji beras, guna mencegah risiko fluorosis akibat tertelan.¹⁰

Melalui kolaborasi antara program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu dan poli gigi Puskesmas, menu camilan posyandu dapat diarahkan pada buah potong berserat (seperti apel dan pir) yang mendukung pembersihan alami rongga mulut (*self-cleansing*). Langkah ini bertujuan mengurangi konsumsi biskuit manis dan lengket yang dapat memicu demineralisasi gigi sulung. Pendekatan integratif ini diharapkan efektif dalam mencegah prevalensi ECC pada anak-anak di Baruga dan Wundudopi.¹³

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada kegiatan Posyandu di wilayah Kelurahan Baruga dan Kelurahan Wundudopi, masih ditemukan kejadian karies pada ibu hamil maupun balita. Pada kelompok ibu hamil, di Kelurahan Baruga ditemukan sebanyak 9 orang (52,9%) mengalami karies, sedangkan di Kelurahan Wundudopi seluruh ibu hamil yang diperiksa yaitu sebanyak 2 orang (100,0%) mengalami karies. Sementara itu, pada kelompok balita, angka karies lebih tinggi secara persentase ditemukan di Kelurahan Wundudopi yaitu sebanyak 5 orang (55,6%) dibandingkan Kelurahan Baruga sebanyak 23 orang (42,6%).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa karies masih menjadi salah satu masalah kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita di wilayah kerja Puskesmas Lapo-Lepo. Oleh karena itu, diperlukan upaya promotif dan preventif secara berkelanjutan melalui pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan, edukasi kesehatan gigi, serta keterlibatan kader Posyandu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini.

5.2 Saran

Diharapkan Puskesmas bersama tenaga kesehatan dan kader Posyandu dapat meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara rutin pada ibu hamil dan balita. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut serta melakukan pemeriksaan gigi secara berkala guna mencegah terjadinya karies.

DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization (WHO). WHO expert consultation on public health interventions against early childhood caries. Bangkok: WHO; 2016.
2. Machiulskiene V, Campus G, Carvalho JC, Dige I, Ekstrand KR, Jablonski-Momeni A, et al. Terminology of Dental Caries and Dental Caries Management: Consensus Report of a Workshop Organized by ORCA and Cariology Research Group of IADR. *Caries Res.* 2020;54(1):7-14.
3. Apro V, Susi S, Sari DP. Dampak Karies Gigi Terhadap Kualitas Hidup Anak. *Andalas Dental Journal.* 2020;8(2).
4. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2024.
5. Sulastrri. Dinamika Masalah Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi.* 2025;3(3):156-166.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Provinsi Sulawesi Tenggara Risdas 2018. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2019.
7. Slat GC, Khoman JA, Bernadus JBB. Worsening factors and current treatments of periodontal disease during pregnancy: A literature review. *e-GiGi.* 2021;9(2).
8. Pinanty A, Suwargiani AA, Susilawati S. Caries experience and periodontal status of pregnant women. *Padjadjaran Journal of Dental Researchers and Students.* 2020;4(1):15-20.
9. Kurniawati D, Ediningtyas K. Pengaruh karies gigi pada ibu hamil terhadap pertumbuhan janin dalam kandungan. *Jurnal Ilmu Kedokteran Gigi.* 2021;4(2):46-51.
10. American Academy of Pediatric Dentistry. Policy on Early Childhood Caries (ECC): Classifications, Consequences, and Preventive Strategies. *The Reference Manual of Pediatric Dentistry.* Chicago: AAPD; 2021. p. 95-106.
11. Khodke S, Naik S, Agarwal N. Infant Dietary Pattern and its Association with Early Childhood Caries in Preschool Children: A Cross-sectional Study. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2023;16(3):421-425.
12. Setiawan AS, Darwita RR, Susilawati S, Maharani DA, Djais AA. Risk factors for early childhood caries based on identification of *Veillonella* spp. using RT-PCR. *Pesqui Bras Odontopediatria Clin Integr.* 2020;20:e5701.
13. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM). Cetakan ke-3. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2004.
14. Salikun, Harapan IK, Marlindayanti. Kurikulum dan Modul Pelatihan Kader Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM). Semarang: Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang; 2021.
15. Sofian R, Pudentiana RE, Kasihani NN, Lestari SY, Anggreni E, Nurbayani S, dkk. Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu untuk Meningkatkan Status Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat. *GEMAKES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.* 2025;5(3):365-370.
16. Susi S, Pujiastuty A, Wulandari Y. Pelatihan kader posyandu untuk peningkatan kesehatan gigi balita di nagari batu hampa, pesisir selatan. *Promotif Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.* 2025;5(1):128-140.
17. Nisa NLR. Pengetahuan Kesehatan Gigi dan Mulut Dengan Kejadian Karies Gigi Pada Ibu Hamil di Puskesmas. *Journal of Oral Health Care.* 2024;11(2):87-92.